

Epidemiologische surveillance van kinkhoest

Bordetella pertussis- 2025

26 mei 2026

Auteurs: I. Peeters¹ • A. Litzroth¹ • I. Desombere² • H. Martini³ • E. Van Honacker³
Revisie: C. Boulouffe⁴ • P. Carrillo⁵ • F. Rolin⁶ • N. Hammami⁷

¹Epidemiologie van infectieziekten, Sciensano; ²Nationaal referentiecentrum voor *Bordetella pertussis* (associatiepartner met het UZ Brussel), Sciensano; ³Nationaal referentiecentrum voor *Bordetella pertussis*, UZ Brussel; ⁴Agence pour une Vie de Qualité; ⁵Office de la Naissance et de l'Enfance; ⁶Vivalis; ⁷Departement Zorg

Hoofdpunten

Sterke daling van kinkhoestgevallen in 2025

In 2025 werden er door het NRC 202 kinkhoestgevallen gerapporteerd, een duidelijke afname tegenover de epidemische piekjaren 2023 (1048 gevallen) en 2024 (3404 gevallen).

Zuigelingen onder één jaar blijven de belangrijkste risicogroep

Hoewel zuigelingen onder één jaar slechts 15% van de gemelde gevallen vertegenwoordigen (64/427), zorgen ze voor bijna 50% van de hospitalisaties (18/37) volgens de gegevens van de verplichte melding.

Verbetering van de maternale vaccinatiegraad voor kinkhoest blijft noodzakelijk

Door het hoge aandeel hospitalisaties bij jonge zuigelingen, waarvan een derde vóór de leeftijd waarop de basisvaccinatie start, blijft inzetten op maternale vaccinatie essentieel. Ondanks de aanbeveling door de Hoge Gezondheidsraad sinds 2013 en de gratis beschikbaarheid van het vaccin, bestaan er nog aanzienlijke regionale verschillen in vaccinatiegraad.

Een survey bij huisartsen en gynaecologen in 2025 bracht meerdere drempels voor het aanbevelen van maternale kinkhoestvaccinatie in kaart, waaronder taalbarrières, tijdsgebrek en gedeelde verantwoordelijkheid tussen zorgverleners. In de Franstalige gemeenschap werd bovendien een beperkte toegang tot het gratis beschikbare vaccin gerapporteerd.

INHOUDSOPGAVE

1. Beschrijving van de surveillance	4
1.1. Gegevensbronnen	4
1.2. Gevalsdefinitie	4
1.3. Representativiteit van de gegevens	5
2. Resultaten	6
2.1. Trends per jaar en gewest	6
2.2. Trends per leeftijdsgroep	7
2.2.1. Alle leeftijden	7
2.2.2. Zuigelingen onder één jaar	8
2.3. Hospitalisatie en vaccinatiestatus	9
2.3.1. Hospitalisaties	9
2.3.2. Vaccinatiestatus	9
2.4. Sterftcijfers	10
3. Belang voor de volksgezondheid	11
4. Meer informatie	12
5. Bijlage	12

1. Beschrijving van de surveillance

De surveillance van kinkhoest¹ in België is gebaseerd op verschillende gegevensbronnen, die in dit rapport geïntegreerd worden besproken.

1.1. Gegevensbronnen

- Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor *Bordetella pertussis*: Dit is een samenwerking tussen UZ Brussel en Sciensano, waarbij het UZ Brussel instaat voor PCR, kweek, confirmatie en typering van stammen, en Sciensano voor anti-pertussistoxine IgG-bepaling.
- Verplichte meldingen: Kinkhoest is meldingsplichtig in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
- Netwerk van peillaboratoria (Epilabo): Het door Sciensano georganiseerde netwerk van vrijwillig deelnemende peillaboratoria verzamelt systematisch diagnostische laboratoriumgegevens, waarbij zowel door serologie als door PCR bevestigde gevallen van *B. pertussis* worden gerapporteerd.
- Netwerk van huisartsen en pediaters, PediSurv: Sinds juni 2022 is ernstige kinkhoest bij kinderen onder 3 jaar, die gehospitaliseerd zijn, opgenomen in de surveillance (de inclusiecriteria kan u hier terugvinden). Deelnemende artsen krijgen maandelijks een uitnodiging met de vraag eventuele gevallen te registreren. Indien er zich geen gevallen voordeden, wordt de arts gevraagd dit te bevestigen door het versturen van een 'nulmelding'.
- Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG): Alle niet-psychiatrische ziekenhuizen in België zijn verplicht om anonieme administratieve, medische en verpleegkundige gegevens met betrekking tot alle ziekenhuisopnames te registreren. Sinds 2015 worden ziekten gecodeerd volgens de International Classification of Diseases, 10e versie (ICD-10-CM). De gegevens zijn beschikbaar met een vertraging van ongeveer twee jaar. Zie bijlage 1 voor meer informatie.
- Mortaliteitsgegevens: Statbel verzamelt en centraliseert informatie, via overlijdensakten geregistreerd door de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Informatie is beschikbaar via de webapplicatie SPMA. Sinds 1998 wordt de ICD-10 gebruikt om de doodsoorzaken te coderen. De codes "A37.0" (Kinkhoest door *B. pertussis*) en "37.9" (kinkhoest, pathogeen niet gespecificeerd) werden gebruikt. De gegevens zijn beschikbaar met een vertraging van drie jaar.

1.2. Gevalsdefinitie

Bron: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Klinische criteria:

Aanhoudende hoestbuien langer dan 2 weken EN minstens één van de volgende:

- paroxysmale hoest
- piepende inhalatie
- braken na hoest

OF

Iedere persoon gediagnosticeerd met pertussis door een arts

OF

Apnoe-episodes kinderen jonger dan 1 jaar

Laboratoriumcriteria:

¹ Recente rapporten en meer info over kinkhoest vindt u op onze website onder het gezondheidsonderwerp 'Kinkhoest'.

Ten minste één van de volgende:

- isolatie van *B. pertussis* uit een klinisch specimen
- detectie van *B. pertussis* in een klinisch specimen via PCR
- specifieke *B. pertussis* antilichaamrespons, hierbij dient rekening gehouden te worden met de vaccinatiestatus.

Epidemiologische criteria:

Epidemiologische link door mens-op-mens transmissie

Classificatie van gevallen

- Mogelijk geval: patiënt die voldoet aan klinische criteria.
- Waarschijnlijk geval: patiënt die voldoet aan klinische en epidemiologische criteria.
- Bevestigd geval: patiënt die voldoet aan klinische criteria en laboratoriumcriteria.

1.3. Representativiteit van de gegevens

Het klinische beeld van kinkhoest is variabel en niet elk geval wordt getest. Geen van de surveillancenetwerken voor pertussis is exhaustief. Ze laten dus niet toe om het exacte aantal pertussisgevallen in België te bepalen, maar worden gebruikt om epidemiologische trends op te volgen.

Voor de NRC gegevens zien we sinds de start van de PCR-terugbetaling in 2019, zoals verwacht, een daling in het aandeel van de door het NRC uitgevoerde PCR's ten opzichte van het totale aantal terugbetaalde PCR's (2019: 64%, 2023: 30%). De volledigheid van de NRC-gegevens voor bevestigde gevallen is dus wellicht gedaald. Ook voeren verschillende laboratoria multiplex-testen uit (een combinatietest waarbij verschillende respiratoire kiemen in één keer opgespoord worden), wat er eveneens verder voor kan zorgen dat het testtaandeel van het NRC kleiner wordt.

Het Epilabo-surveillancesysteem is gebaseerd op vrijwillige deelname van laboratoria. In 2025 waren er 36 deelnemende laboratoria (tegenover 37 in 2024), voornamelijk in Vlaanderen. Absolute aantallen kunnen dus niet zomaar vergeleken worden tussen regio's. Als we de analyses beperken tot labo's die continu rapporteerden doorheen de tijd, zien we dezelfde trends als bij analyses waarin alle labo's worden geïncludeerd.

Het PediSurv netwerk heeft een bereik in heel België met deelname van 219 pediaters (België) en huisartsen (Brussel) in 2025. Naar schatting worden 52% van de pediatrische hospitalisaties gedekt door ziekenhuizen die deelnemen aan het netwerk.

In Vlaanderen omvat de meldingsplicht mogelijke gevallen (met waarschijnlijke laboratoriumcriteria), waarschijnlijke gevallen en bevestigde gevallen. In Wallonië en Brussel beperkt de meldingsplicht zich tot bevestigde gevallen. Bovendien gold in Wallonië van 2020 tot november 2023 enkel een meldingsplicht voor gevallen bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Bij de minimale ziekenhuisgegevens moet in rekening gebracht worden dat ze aanvankelijk niet voor epidemiologische doeleinden verzameld werden en diagnose en codering van ziekten kunnen variëren tussen ziekenhuizen.

2. Resultaten

2.1. Trends per jaar en gewest

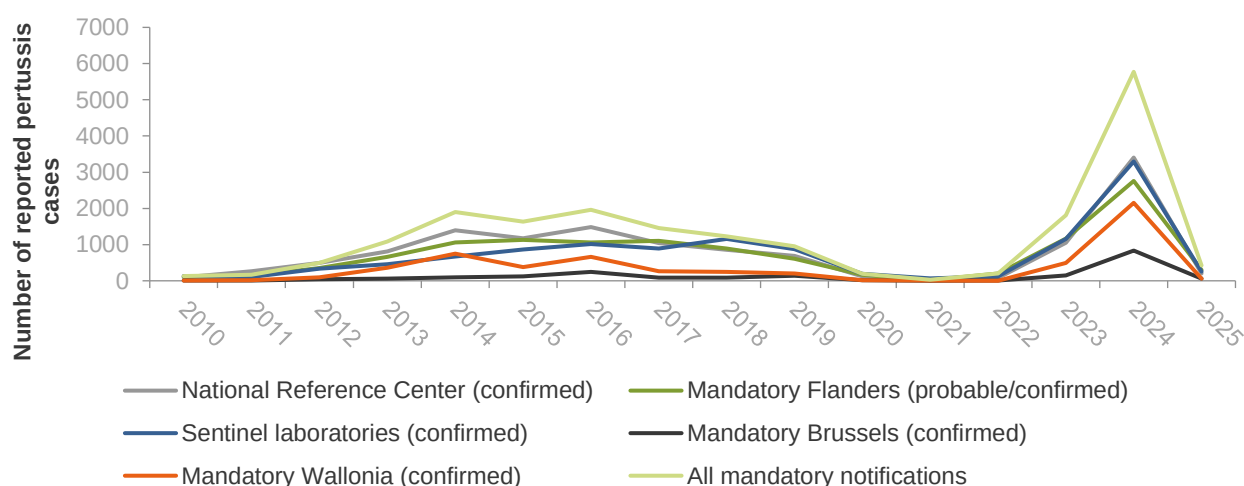
Het jaarlijkse aantal kinkhoestgevallen wordt weergegeven in Figuur 1. Na de verhoogde kinkhoestcirculatie van augustus 2023 tot en met september 2024 bleef het aantal gevallen gerapporteerd door het NRC laag in 2025, met 202 gevallen tegenover 1048 in 2023 en 3404 in 2024.

In 2025 kwamen 107 van de 202 bevestigde NRC stalen uit Vlaanderen (53%), 37 uit Wallonië (18%) en 58 uit Brussel (29%). Het betreft 141 PCR resultaten (69%), 59 serologie resultaten (29%) en twee resultaten van gecombineerde analyses (1%).

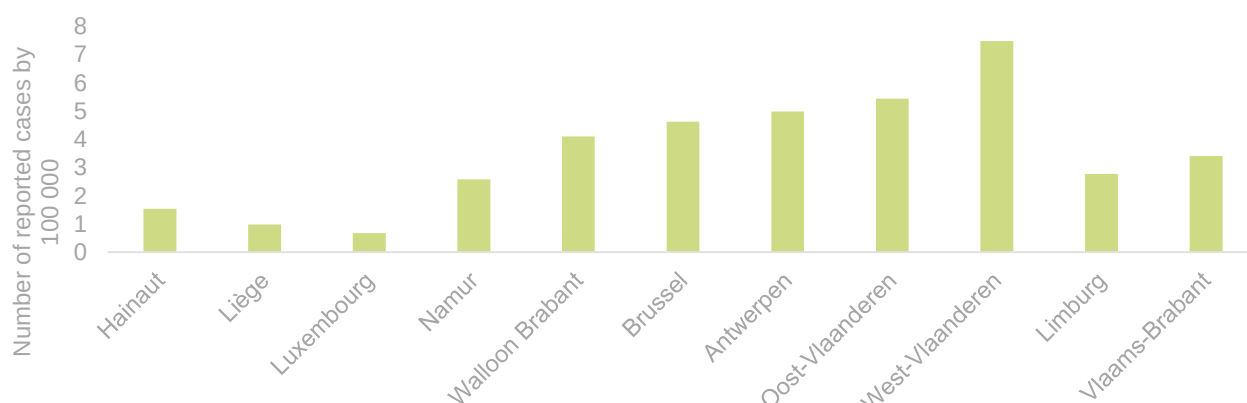
Van de 427 verplicht gemelde kinkhoestgevallen in 2025 werden er 302 (71%) in Vlaanderen gemeld (waarvan 274 bevestigd en 28 waarschijnlijk), 64 bevestigde gevallen (15%) in Wallonië en 58 bevestigde gevallen (14%) in Brussel.

De gerapporteerde incidentie volgens de verplichte melding in 2025 in België bedroeg 3,6 per 100 000 personen, maar varieerde naargelang provincie en databron. (Figuur 2).

Figuur 1: Aantal gevallen van kinkhoest volgens gegevensbron, België, 2010-2025 (Bronnen: peillaboratoria, verplichte melding, nationaal referentiecentrum voor *Bordetella pertussis*)



Figuur 2: Aantal gevallen van kinkhoest in 2025 per 100 000 populatie per provincie (Bronnen: verplichte melding, Statbel)



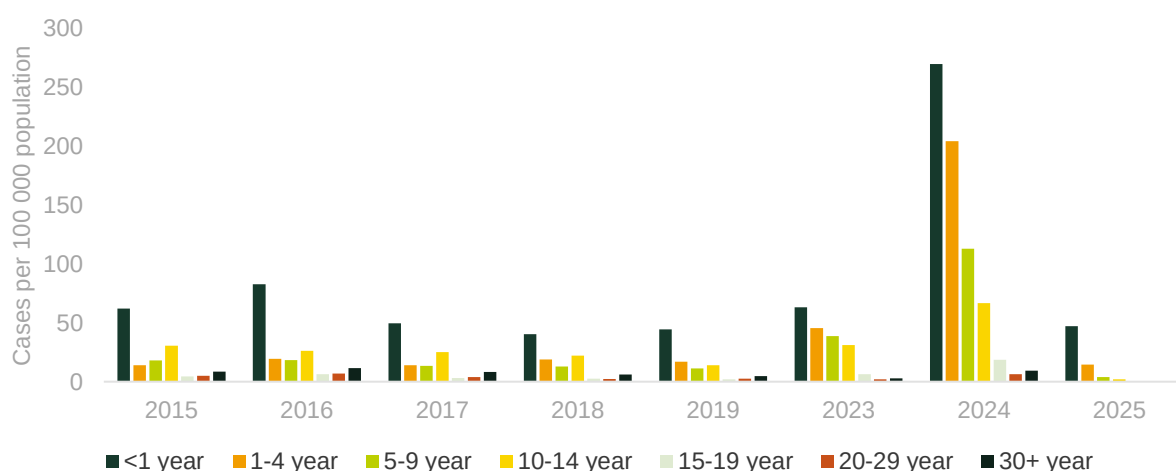
2.2. Trends per leeftijdsgroep

2.2.1. Alle leeftijden

Volgens de gegevens van het NRC was er een daling in alle leeftijdsgroepen in 2025, tegenover het piekjaar 2024. De hoogste gerapporteerde incidentie, blijft te zien bij zuigelingen onder één jaar en 1-4 jarigen (Figuur 3).

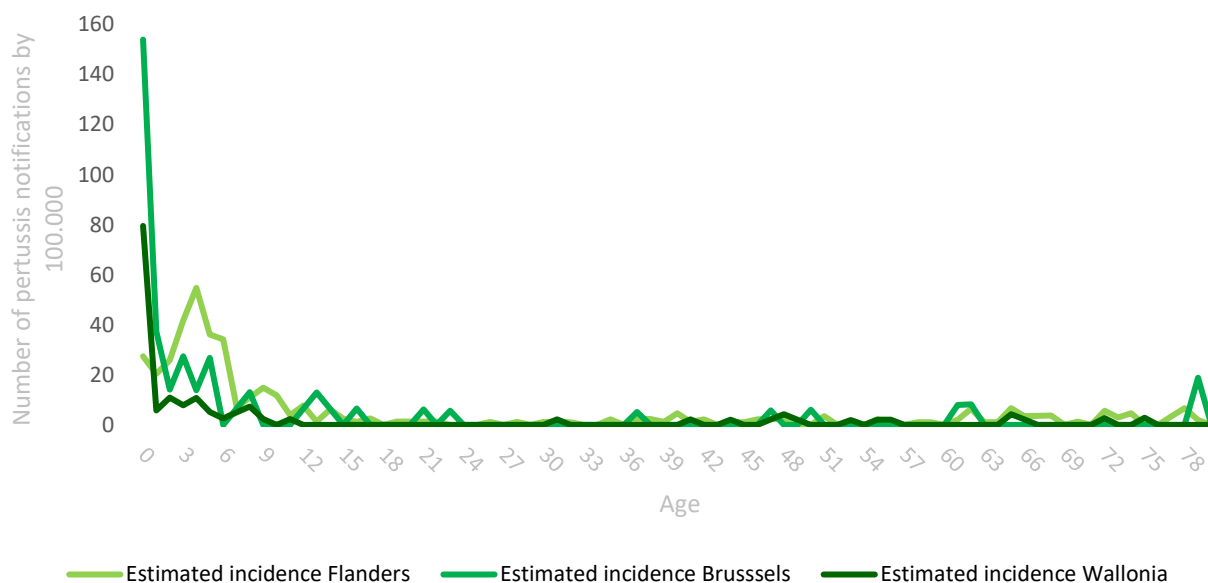
Net zoals in 2024 was de hoogste piek in de gerapporteerde incidentie volgens de verplichte melding te zien voor zuigelingen onder één jaar in Brussel en Wallonië, maar niet in Vlaanderen. Een mogelijke verklaring kan liggen in verschillen in maternale vaccinatiegraad (85% Vlaanderen; 39% Wallonië; 31% Brussel volgens cijfers uit 2019), hoewel ook andere factoren, zoals test- en meldingspraktijken, een rol kunnen spelen (Figuur 4).

Figuur 3: Verdeling van pertussis gevallen per 100 000 populatie, per leeftijdsgroep* (Bronnen: NRC en Statbel)



*De jaren 2020-2022 met lage aantallen pertussisgevallen werden niet weergegeven.

Figuur 4: Aantal gemelde gevallen van pertussis per leeftijd voor 2025, per 100 000 inwoners per jaar (Bronnen: verplichte melding en Statbel)

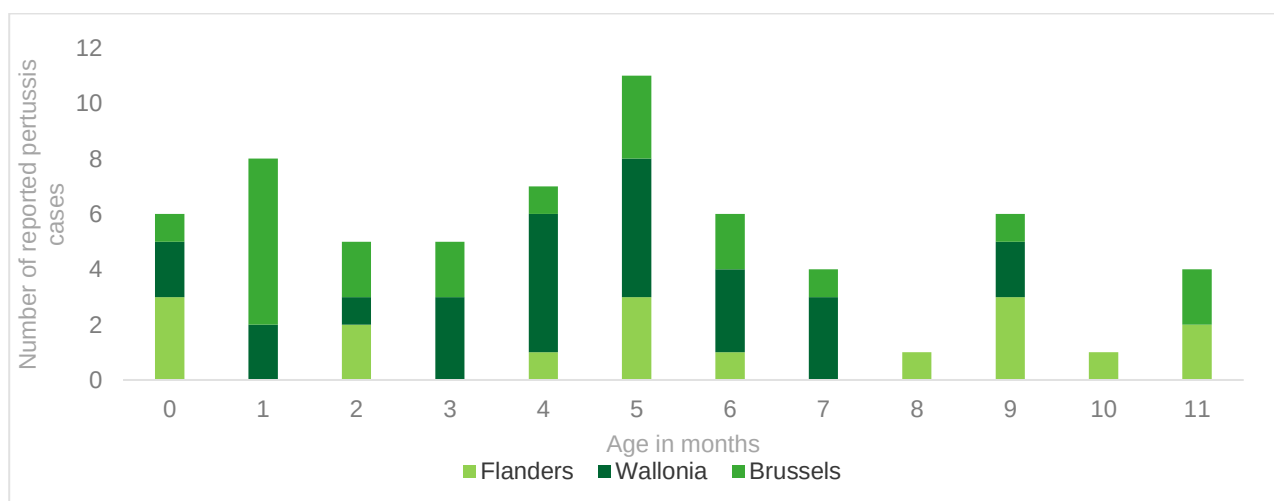


2.2.2. Zuigelingen onder één jaar

Volgens de gegevens van het NRC komen 51 gevallen van de 202 (25%) uit de leeftijdsgroep onder één jaar. In Vlaanderen betreft dit 8/107 gevallen (7%), in Wallonië 18/37 gevallen (49%) en in Brussel 25/58 gevallen (43%).

Volgens de verplichte meldingen werden er 64 gevallen gemeld bij zuigelingen onder één jaar (waarvan 17 in Vlaanderen, 26 in Wallonië en 21 in Brussel) (Figuur 5). Twee derde van de gemelde kinkhoestgevallen onder één jaar treft zuigelingen onder de leeftijd van 6 maanden.

Figuur 5: Aantal gemelde pertussis gevallen per regio onder één jaar, 2025. (Bron: verplichte melding)



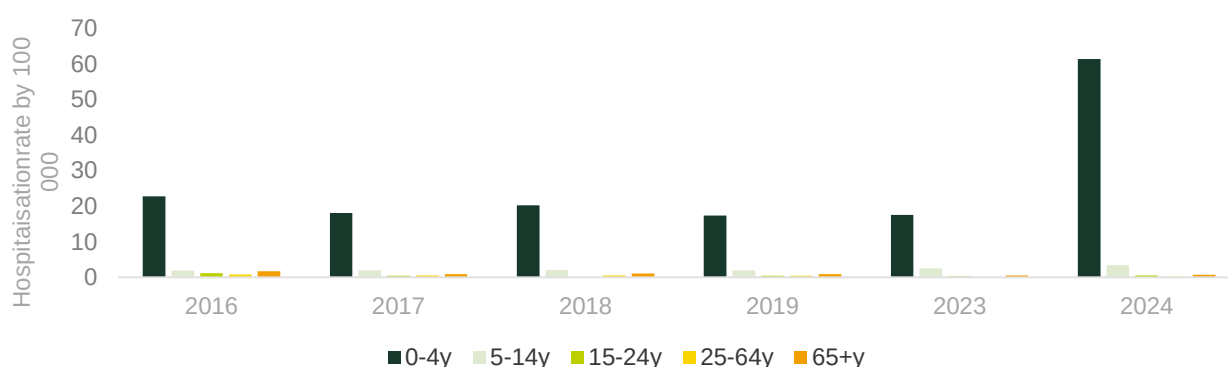
2.3. Hospitalisatie en vaccinatiestatus

Informatie over hospitalisatie en vaccinatiestatus is vaak onvolledig in onze gegevensbronnen. De meest volledige bron voor 2025 is de verplichte melding.

2.3.1. Hospitalisaties

Informatie uit de Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG, bijlage 1) geeft aan dat het merendeel van hospitalisaties omwille van kinkhoest in de 0- tot 4-jarigen plaatsvindt. In 2024 (laatst beschikbare gegevens) was er ten gevolge van de kinkhoestepidemie duidelijk een forse toename van de hospitalisaties in deze meest getroffen leeftijdsgroep. Daarbij deed 78% van de hospitalisaties bij 0- tot 4-jarigen zich voor bij zuigelingen jonger dan één jaar (Figuur 6).

Figuur 6: Hospitalisatiegraad omwille van kinkhoest per leeftijdsgroep (Bron: Minimale Ziekenhuis Gegevens, Statbel)



**De jaren 2020-2022 met lage aantallen pertussisgevallen werden niet weergegeven.*

In de verplichte melding telde Vlaanderen 27 hospitalisaties in 2025 (9% van de gemelde gevallen, in 39% ontbrak informatie). Wallonië telde negen hospitalisaties in 2025 (14% van de gemelde gevallen, de informatie was volledig). Brussel telde één hospitalisatie in 2025 (2% van de gemelde gevallen, in 53% ontbrak informatie).

In Vlaanderen waren negen van de 27 hospitalisaties bij deze zuigelingen onder één jaar; in Wallonië ging het over acht van de negen hospitalisaties en in Brussel betrof het de enige gemelde hospitalisatie. Een derde van deze hospitalisaties bij zuigelingen onder één jaar gebeurt op een leeftijd voor de basisvaccinatie start.

In PediSurv werden er in 2025 vijf gevallen geregistreerd waarvan drie gevallen in Vlaanderen en twee in Wallonië. De gemiddelde hospitalisatieduur was twee dagen (interval 1-5 dagen). Geen van de gevallen had een onderliggende comorbiditeit. Er werden geen patiëntjes opgenomen op intensieve zorgen.

2.3.2. Vaccinatiestatus

Gegevens over vaccinatiestatus waren beschikbaar via de verplichte meldingen voor 60% van de gevallen in Vlaanderen, 55% van de gevallen in Wallonië en 30% van de gevallen in Brussel.

Tabel 1 geeft vaccinatiestatus in combinatie met hospitalisatiegegevens weer voor zuigelingen onder één jaar, per regio. Hospitalisaties kwamen voornamelijk voor in de groep 'te jong voor vaccinatie' (6/14) en de groep 'niet volgens schema gevaccineerd' (5/7), hoewel de interpretatie wordt bemoeilijkt door het beperkte aantal gevallen en de ontbrekende informatie voor een aanzienlijk deel van de gevallen.

Tabel 1. Vaccinatiestatus en hospitalisatiestatus van alle gemelde pertussisgevallen onder één jaar per regio, 2025 (Bron: verplichte melding)

Regio	Vaccinatiestatus	n	Hospitalisatiestatus		
			Ja	Neen	Onbekend
Vlaanderen	Te jong voor vaccinatie	3	2	0	1
	Gevaccineerd volgens schema	9	4	4	1
	Niet volgens schema gevaccineerd	3	2	0	1
	Ontbrekende info	2	1	1	0
	Totaal	17	9	5	3
Wallonië	Te jong voor vaccinatie	4	3	2	0
	Gevaccineerd volgens schema	16	2	14	0
	Niet volgens schema gevaccineerd	3	3	0	0
	Ontbrekende info	3	0	3	0
	Totaal	26	8	19	0
Brussel	Te jong voor vaccinatie	7	1	0	6
	Gevaccineerd volgens schema	4	0	4	0
	Niet volgens schema gevaccineerd	1	0	1	0
	Ontbrekende info	9	0	3	6
	Totaal	21	1	8	12

Enkel in Vlaanderen was er info over maternale vaccinatie beschikbaar. Deze was correct uitgevoerd bij vijf van de negen moeders van pertussisgevallen jonger dan zes maanden, waarvan drie gevallen werden opgenomen in het ziekenhuis. Eén van de negen moeders was niet gevaccineerd, dit kind werd gehospitaliseerd en bij de overige drie gevallen was de informatie onbekend (alle drie de gevallen werden gehospitaliseerd).

2.4. Sterftcijfers

Er was één overlijden van een 80-plusser in Vlaanderen, gemeld als een waarschijnlijk kinkhoestgeval in 2025 via de verplichte melding. Via informatie uit de overlijdensaktes (meer informatie zie bijlage 2) tussen 2010 en 2023 (meest recente informatie) weten we dat er 13 personen ten gevolge van kinkhoest overleden zijn (ICD-10 A37.0 en A37.9). Het betrof zeven overlijdens van kinderen onder één jaar (waarvan twee in 2023 plaatsvonden).

3. Belang voor de volksgezondheid

Na de kinkhoestepidemie in 2023-2024 werd in 2025 een duidelijke daling van het aantal gerapporteerde kinkhoestgevallen gezien, in lijn met het gekende cyclische epidemische verloop van kinkhoest. Ondanks deze daling bleef de gerapporteerde incidentie hoog bij zuigelingen onder één jaar, voornamelijk in Wallonië en Brussel. Deze groep heeft een verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop en hospitalisatie. Bovendien vindt een derde van de hospitalisaties plaats vóór de start van de basisvaccinatie (op de leeftijd van acht weken).

Voor de start van de basisvaccinatie op acht weken (vaccinatie coverage 3^e DTP dosis van 97,5% volgens gegevens 2019) kunnen de allerjongste zuigelingen enkel indirect beschermd worden via vaccinatie van de zwangere vrouw tijdens iedere zwangerschap. Maternale vaccinatie heeft een hoge effectiviteit (tot 97% bescherming tegen mortaliteit bij de pasgeborenen²). Hoewel deze vaccinatie sinds 2013 wordt aanbevolen en gratis beschikbaar is in alle gefedereerde entiteiten, bestonden er in 2020 nog aanzienlijke regionale verschillen in vaccinatiegraad (85% in Vlaanderen, 39% in Wallonië en 31% in Brussel).

Een survey uitgevoerd eind 2025 bij huisartsen en gynaecologen bracht verschillende drempels voor het aanbevelen van maternale kinkhoestvaccinatie in kaart. In alle regio's werden vooral taalbarrières, tijdsgebrek tijdens consultaties en de veronderstelling dat een andere zorgverlener de vaccinatie zal bespreken, als belangrijkste knelpunten genoemd. Verder bleek de toegang tot het gratis beschikbare vaccin in de Franstalige gemeenschap beperkt te zijn. In samenwerking met de bevoegde gefedereerde entiteiten en beroepsverenigingen zullen verbeteracties worden opgezet, waaronder gerichte communicatie over de regionaal beschikbare meertalige informatiematerialen en de huidige terugbetalingsmodaliteiten.

Gezien immuniteit na vaccinatie of doormaken van de ziekte niet levenslang is en volwassenen asymptomatisch of licht symptomatisch kunnen zijn, maar wel een bron van infectie voor kwetsbare jonge kinderen vormen, raadt de Hoge Gezondheidsraad alle volwassenen éénmalig een extra booster dosis aan van het pertussisvaccin, ongeacht hun vaccinatiestatus. Aangezien er voor de vaccinatie van volwassenen echter enkel nog een gecombineerd vaccin difterie-tetanus-pertussis beschikbaar is en het advies van de Hoge Gezondheidsraad is om volwassenen om de 10 jaar te hervaccineren tegen tetanus, komt dit in praktijk ook voor kinkhoest neer op een herhalingsdosis om de 10 jaar. Kinkhoest is meldingsplichtig zodat, indien nodig, tijdige chemoprophylaxis gestart kan worden om kwetsbare gezinsleden te beschermen.

² Amirthalingam G, Campbell H, Ribeiro S, Stowe J, Tessier E, Litt D, et al. Optimization of Timing of Maternal Pertussis Immunization From 6 Years of Postimplementation Surveillance Data in England. Clin Infect Dis. 2023 Feb 1;76(3):e1129–39.

4. Meer informatie

- Verdere informatie over kinkhoest in het kader van de meldingsplicht: <https://www.departementzorg.be/nl/infectieziekte/kinkhoest-pertussis>
- Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad rond kinkhoestvaccinatie:
 - Volwassenen: <https://www.hgr-css.be/nl/advies/9110/vaccinatie-van-volwassenen-tegen-kinkhoest>
 - Kinderen: <https://www.hgr-css.be/nl/advies/8807/vaccinatie-tegen-difterie-tetanus-en-kinkhoest-bij-kinderen>
 - Vaccinatie tijdens zwangerschap: <https://www.hgr-css.be/nl/advies/8754/immunisatie-tijdens-de-zwangerschap>

Vermoedt u een geval van KINKHOEST ?

Vlaanderen: [Klik hier](#)

Brussel: [Klik hier](#)

Wallonië : [Klik hier](#)

5. Bijlage

Bijlage 1: Gegevens ziekenhuisopname

Het aantal ziekenhuisopnames in verband met kinkhoest werd verkregen aan de hand van gegevens uit de Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG) registratiesysteem van administratieve, medische en verpleegkundige gegevens met betrekking tot alle ziekenhuisopnames waaraan alle niet psychiatrische ziekenhuizen in België verplicht moeten bijdragen. Ziekten worden sinds 2015 gecodeerd volgens de "International Classification of Diseases", 10e versie (ICD-10). De volgende ziekenhuisverblijven werden in aanmerking genomen: conventionele ziekenhuisopname en niet-chirurgische dagopname. De hoofddiagnosen³ werden gebruikt. De volgende codes werden gebruikt: A37 Kinkhoest.

Bijlage 2: Sterftegegevens overlijdensakte

Statbel centraliseert de sterftegegevens geregistreerd door de Vlaamse en Franse Gemeenschap en stelt ze beschikbaar via de SPMA-applicatie. Sinds 1998 wordt de "International Classification of Diseases", 10e versie (ICD-10-CM) gebruikt om de doodsoorzaken te coderen. De codes "A37.0" (Kinkhoest door B. pertussis) en "37.9" (kinkhoest, pathogeen niet gespecificeerd) werden gebruikt. Voor dit verslag werden gegevens tussen 2010 en 2023 geanalyseerd.

³ De hoofddiagnose is "de aandoening die bij onderzoek de voornaamste oorzaak bleek te zijn van de opname van de patiënt".

CONTACT

Ilse Peeters • ilse.peeters@sciensano.be

OVER SCIENSANO

Sciensano is een openbaar en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, dat zich inzet voor de gezondheid van mens en dier en hun omgeving.

We doen wetenschappelijk onderzoek en surveillance, en ondersteunen de overheid en verschillende agentschappen en organisaties met expertise, adviezen en diensten op vlak van gezondheid.

Sciensano hecht veel belang aan het One Health-principe, dat benadrukt dat de gezondheid van mens, dier en hun omgeving onderling verbonden zijn. Daarom is ons onderzoek interdisciplinair en integreert het verschillende invalshoeken.

Met meer dan duizend medewerkers en 120 jaar aan wetenschappelijke expertise, is Sciensano een gerenommeerd wetenschapsinstituut, dat deel uitmaakt van verschillende internationale wetenschappelijke netwerken.

MEER INFO

Sciensano.be – info@sciensano.be

Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • T + 32 2 642 51 11